



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : صفاء قاسم عبدالحليم عبدالحفيظ

العنوان : المعصره حلوان

الحي / المدينة : حلوان

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 04-10-2026

رقم البطاقة : 28104010106341 رقم التليفون : 01151146690

العمر (تاريخ الميلاد) : 01-04-1981 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني الوظيفة: التوقيع:
الاسم: د/ندى حسن الوظيفة: التوقيع:
الاسم: د/نرمين رمضان الوظيفة: التوقيع:
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: صفاء قاسم عبدالحليم عبدالحفظ National ID: 28104010106341	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



عند
مقتضى



PATHOLOGY DEPARTMENT
HISTOPATHOLOGICAL REPORTPatient name: صفاء قاسم عبدالحليم
عبدالحفيظ

Age: 45 years

Sex: female

Request type: مبادره

Hospital no:

Sub request type:

Department: صحة مرآه

Pathology no.: 735-2026

Referred by: د/امينه يسري

Date of result: 8/8/2026

Nature of specimen: tru-cut biopsy

Date of biopsy: 29/7/2026

Clinical diagnosis: Left breast mass

I.D. Number: 28104010106341

Gross pathology:

Multiple fragmented grayish white tissue cores up to 0.5x0.4cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against ER- PR- Her2- Ki67

Microscopic picture: Section examined revealed core of tumor showing invasive duct carcinoma of no special type (NST). The tumor forms nests, tubule and cribriform pattern infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showing marked anaplasia and mild tendency to form tubules. There is moderate number of mitotic figuresImmunohistochemical Result

ER: Strong nuclear staining in 90% of tumor cells (Allred Score 8/8).

PR: Strong nuclear staining in 90% of tumor cells (Allred Score 8/8).

Her2: Strong complete membranous staining in >10% of tumor cells (score 3+).

Ki67: Positive nuclear staining of 70% of tumor cells.

Diagnosis: Left breast mass, tru-cut biopsy:

Invasive duct carcinoma (NST), Grade III.

Signature:

Dr.Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

اسم المريض: Safaa Kasem Abd Alhaleem, Addi Alhafiz	كود المريض: 97632
تاريخ التقرير: 2025/07/28 11:13:52 AM	السن: ٤٥ سنة, ٣ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 45 years old female patient with left breast lump.

Detailed Findings

Left breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- The left breast shows posterior 1/3 large ill-defined spiculated dense mass lesion with obscured margins and architectural distortion and abutting the underlying muscles and located at LIQ
- Ultrasound revealed large ill defined hypoechoic mass lesion (at lower breast fold) measures about 5.0 x 3 cm at its maximum diameters and located 7 ° clock position. It is seen focal no line of cleavage with the underlying muscle suggestive of muscle invasion. the lesion also shows invasion to the skin layer
- Normal nipple/areolar complex.
- Multiple enlarged axillary lymph nodes at level I, II with effaced hila, largest one measures about 32 x 12.8 mm at level II.
- an enlarged solitary infraclavicular lymph node measures about 18 x 8 mm.

Right breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Ultrasound demonstrated prominent glandular elements of the breast tissue with mottled appearance.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- Left breast (BIRADS 5): left LIQ malignant mass lesion with ipsilateral pathological axillary and Infraclavicular lymph nodes as described. For tru cut biopsy
- Right breast (BIRADS 2): fibroadenosis .

Much obliged,

Marwa a. el seoud

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصريةالهيئة العامة
للتنظيم الأسرة

09/28/2026

MDT FORM

Name:	صفاة خالد عبداللطيف عبداللطيف	MRN:	13172
Age:	46 Y	ID:	28104010106341
Menopausal Sta		Phone:*	01151146690
NRS SCORE:		Marital Status:	MARRIED
BMI:		Family History:	-VE
Gender		Reason Of MDT:	NEW CASE
CO Morbidty:	FREE	ECOG Performance Status	0 1 2 3 4
Surgical History:*	FREE		

Clinical Data:

R L

BX: IDC G 3
ER: 8/8 PR: 8/8 HER2: 3 KI67: 70

History:

Sonomammography:

SM
LT POST THIRD LARGE ILL DEFINED DENSE MASS ABUTTING THE UNDERLYING MUSCLES AT LIQ 5*3 CM NO LINE OF CLEAVAGE SUGGESTING MUSCLE INVASION AND SHOW SKIN INVASION MULTIPLE ENLARGED AXILLARY LN AT LEVEL 1 AND 2 LARGEST 32*12 MM .AN ELARGED SOLITARY INFRACLAVICULAR LN 18*8 MM

Biomarker/Molecular

Met's Workup:

CT CAP FREE
BONE SCAN FREE

Recommendations:

FOR NACT THEN MRM (NIPPLE THICKING AND EDEMA)

MDT Outcome & Plan

PORT-CATH
ECHO
NACT TCHP x 6 cycles THEN MRM

Clinical Staging:

Pathological Staging:

Right Side Left Side

Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د. فريال مصطفى	د. محمد تيرادي		

about:blank